

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Consent Information - Patient Copy Abdominoplasty

معلومات الإقرار – نسخة المريض جراحة شد البطن

1. What do I need to know about this procedure?

This procedure is where a long cut is made across (horizontally) the lower abdomen. Skin and fat will be stripped off the muscles all the way from the pelvis to the rib cage. Skin is then pulled down and excess skin and fat is removed.

This will leave a long, low scar passing out from the centre above the pubic hair out sideways onto each hip. The umbilicus (belly button) will be brought out through a separate opening leaving a small scar which will be as hidden as possible.

2. My anaesthetic

This procedure will require an anaesthetic. See **About Your Anaesthetic information sheet** for information about the anaesthetic and the risks involved. If you have any concerns, discuss these with your doctor.

If you have not been given an information sheet, please ask for one.

3. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse,

1. ما الذي ينبغي عليّ معرفته عن هذا الإجراء؟

في هذا الإجراء يتم عمل شق جراحي أفقي (بالعرض) طويل أسفل البطن. يتم نزع الجلد وطبقة الدهون من العضلات في كامل المنطقة من الحوض إلى القفص الصدري. يتم بعد ذلك سحب الجلد للأسفل حيث يزال الجلد والدهن الفائض. يترك ذلك ندباً طويلاً منخفضاً يمتد من منتصف منطقة أعلى شعر العانة باتجاه عظمة الحوض في الجانبين. يتم إخراج سرة البطن عبر فتحة مستقلة مما يترك ندباً صغيراً يتم إخفاءه قدر الإمكان.

2. التخدير الذي أتلقيه

سوف يتطلب هذا الإجراء الخضوع للتخدير. اقرأ ورقة تعليمات التخدير المقرر لك للمزيد من المعلومات عن نوع التخدير والمخاطر المترتبة عليه. إن كان لديك أي مخاوف أو تساؤلات قم بمناقشتها مع طبيبك المعالج. إذا لم تقدم لك ورقة التعليمات، نرجو عدم التردد في طلبها.

3. ما هي المخاطر المتعلقة بهذا الإجراء بالتحديد ؟

هذا الإجراء له مخاطر ومضاعفات، وهي تشمل، ولكنها غير مقتصرة على:

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى، مما يتطلب العلاج بالمضادات الحيوية وعلاجات أخرى.
- حدوث نزيف مما قد يتطلب العودة مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً لدى من يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبييردامول (بيرسانتن أو اساسانتين).
- قد يحدث انغلاق لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.

- Increased risk in obese people of wound infection, infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

Scars

- There will be a long, horizontal (across) scar, which is usually placed low enough to be hidden by most moderate two-piece bathing costumes. It is noticeable but usually fades in time. There is no guarantee that all swimming garments will hide such scars.
- Sometimes the scars can be red, thick and itchy. The final scar may remain thickened after a period of time. Patients can reduce the risk of this and help the healing of the scars by avoiding over-activity and straining for three to four weeks.
- The pubic hairline may be pulled out towards the hip bones by about 2cm, due to excess tissue taken out to the sides of the abdomen.

Failure of the procedure

- A scar like an upside-down T, or occasionally two scars, a horizontal (crosswise) one and a transverse (up and down) scar due to difficulty in bringing down the skin below the umbilicus to meet the pubis in a horizontal (crosswise) scar.
- Necrosis (dying) of remaining skin due to poor circulation where there is scar tissue.
- Rarely, necrosis (death of skin) near previous surgical scars due to reduction of blood flow to

من مخاطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي (الفيزيائي) للصدر.

- عند المرضى ذو الوزن الزائد أو السمنة المفرطة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.
- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مما يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- الوفاة محتملة كنتيجة لهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء:

الندوب الجراحية

- ينتج عن الجراحة ندب جراحي طويل ومستعرض (أفقي). يتم عادةً وضع هذا الندب في منطقة منخفضة بحيث تسمح بإخفائه عند ارتداء ملابس سباحة مكونة من قطعتين. يكون الندب مرئياً إلا أنه يبهت ويتلاشى مع مرور الوقت. لا يمكن تأكيد أن جميع ملابس السباحة قادرة على إخفاء هذا الندب.
- أحياناً يكون الندب أحمر اللون ، سميك ويسبب الحكة. قد يظل الندب الجراحي النهائي سميكاً بعد فترة من الوقت. يمكن للمريض التقليل من هذا الخطر والمساعدة على التئام الندب بتجنب النشاطات الزائدة عن الحاجة وتجنب وضع ضغط على البطن (الحزق) لفترة 3-4 أسابيع.
- قد يتم سحب خط شعر العانة باتجاه عظمتي الحوض بحدود 2 سنتيمتر بسبب النسيج الفائض الذي تمت إزالته إلى جانبي البطن.

فشل الإجراء

- ندب جراحي على شكل حرف (T) المقلوب ، أو أحياناً ندبين جراحيين أحدهما أفقي بالعرض وآخر طولي بسبب صعوبة جلب الجلد الموجود تحت سرة البطن باتجاه الأسفل ليلتقي مع العانة في الندب الأفقي.
- موت باقي الجلد بسبب ضعف الدورة الدموية في النسيج المتندب.
- من النادر حدوث موت الجلد بالقرب من ندوب جراحية سابقة بسبب ضعف الدورة الدموية في الجلد والدهن في الموضع الذي خضع لجراحة سابقة في البطن (مثل العملية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the skin and fat where there has been previous abdominal surgery (eg. Caesarean section, hysterectomy or gall bladder operation).

Position of umbilicus (belly button)

- The umbilicus may not be central due to difficulty in positioning the umbilicus before surgery, particularly in a patient who has lost a lot of weight.
- Loss of the umbilicus. The scar may provide a reasonable substitute.

Abdominal wall muscles

- Muscle soreness immediately after operation due to the repair of stretched or separate abdominal wall muscles.

Sensory changes

- Numbness of skin pulled down below the umbilicus for up to a year or so, due to disturbance of nerves in the skin and the fat. This may be permanent.
- There may be numbness on each side. This may extend well down on to the thigh. This is usually temporary but can be permanent.

Complications

- Increased risk of clots in the leg for patients who are on the oral contraceptive pill. Part of this clot may break off and go to the lungs, which can be fatal. Oral contraceptives should be stopped prior to operation but only after discussion with the surgeon.
- Collection of fluid under the skin above the horizontal scar. This may take a few weeks to absorb. To avoid fluid collection, limit movement of the abdominal wall in the first week after surgery and keep a firm pressure garment in place as recommended by the surgeon.
- Marked increase of failure of the procedure due to effects of smoking on quality of blood supply to

القيصرية ، استئصال الرحم أو عملية في الحويصلة المرارية).

موضع سرة البطن

- قد لا يكون من الممكن وضع سرة البطن في المنتصف بسبب مشاكل في وضع السرة قبل العملية ، وخاصة عند المرضى الذي فقدوا الكثير من الوزن قبل الجراحة.
- فقدان سرة البطن. قد يوفر الندب الجراحي بديلاً معقولاً.

عضلات جدار البطن

- يشعر المريض بألم مباشرة بعد العملية بسبب إصلاح العضلات المشدودة أو بسبب عضلات جدار البطن.

تغيرات في الإحساس

- خدر في الجلد الذي تم سحبه للأسفل من تحت سرة البطن. يستمر ذلك لما يقارب السنة بسبب اضطراب الأعصاب في الجلد والطبقة الدهنية. قد يكون ذلك دائماً.
- قد يكون هناك خدر في الجانبين. قد يمتد ذلك ليشمل الفخذ. يكون ذلك عادة مؤقت إلا أنه قد يكون دائم.

المضاعفات

- زيادة خطر الإصابة بجلطة في الساق عند السيدات اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل عن طريق الفم. قد ينفصل جزء من هذا الجلطة ويصل إلى الرئة. قد يكون ذلك مميتاً. يجب إيقاف تناول حبوب منع الحمل عن طريق الفم قبل الخضوع للجراحة ، على أن يتم ذلك بعد التشاور مع الجراح.
- تجمع دموي تحت الجلد فوق الندب الأفقي. قد يستغرق امتصاص ذلك عدة أسابيع. لتفادي تجمع السوائل ، يجب على المريض أن يحد من حركة جدار البطن خلال الأسبوع الأول الذي يعقب الجراحة وأن يلتزم بارتداء الملابس الضاغطة كما تم نصحه من قبل الجراح.

- تكون هناك نسبة عالية باحتمال فشل الإجراء بسبب تأثير التدخين على جودة تدفق الدم إلى الجلد في منطقة أسفل



المركز الطبي الدولي
International Medical Center

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

the skin of the lower part of the abdominal wall.

Notes to talk to my doctor about:

جدار البطن.

أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج:
